

1. L'angine virale ne peut être caractérisée par:

- a. une fièvre oscillante, l'anorexie, la dysphagie
- b. rinorrhée, toux sèche
- c. leucocytose
- d. neutrophilies
- e. microvésicules des piliers

2. L'asthme est contrôlé quand l'enfant a:

- a. plus de 3 crises/semaine
- b. moins de 2 crises/semaine
- c. sans limitation de l'activité
- d. besoin du traitement moins de 2 fois/semaine
- e. besoin du traitement moins de 2 fois/jour

3. Complications métaboliques de l'obésité de l'enfant sont:

- a. Diminution de la tolérance au glucose, la glycémie pendant TTGO: $< 126 \text{ mg\%}$ à 0 min et $< 200 \text{ mg\%}$ à 120 min
- b. Diminution de la tolérance au glucose, la glycémie pendant TTGO: $> 126 \text{ mg\%}$ à 0 min
- c. Les altérations du métabolisme protéique: hyperprotinémie, hyperuricémie
- d. Les altérations du métabolisme protéique: Dysprotinémie, hyperuricémie
- e. Les altérations du métabolisme lipidique: Dyslipidémie / hyperlipidémie

4. Le SYNDROME PICKWICK est caractérisé par:

- a. Obésité monstrueuse, principalement abdominale
- b. Obésité monstrueuse, principalement abdominale
- c. Insuffisance respiratoire chronique, dyspnée, cyanose, cœur pulmonaire chronique
- d. Insuffisance respiratoire aiguë, dyspnée, cyanose, cœur pulmonaire aiguë
- e. Hématologique polycythémie

5. Dystrophie II degré est caractérisée par:

- A. Indice nutritionnel = 0,80-0,71
- B. L'activité motrice est normale ou légèrement inférieure
- C. Diminution du métabolisme basal explique la tendance à l'hypothermie et une insuffisance circulatoire
- D. Il est l'état le plus grave du trouble chronique nutritionnel
- E. Courbe de poids est à la baisse dans des étapes

6. Les affirmations suivantes sur les objectifs thérapeutiques en CAD sont vraies:

- A. Correction de l'acidose métabolique par un apport hydrique adapté, insulinothérapie = administration du NaHCO_3
- B. La glycosurie et la cétonurie doivent être surveillé une fois au 8 h
- C. La glycosurie et la cétonurie doivent être surveillé une fois au 3-4 h au moins
- D. La dose d'insuline se baisse seulement après que l'acidose a été corrigée
- E. La dose d'insuline se baisse seulement depuis que l'acidose a été corrigée

7. L'insuline a l'action intermédiaire:

- A. Actionne après 15-30 minutes
- B. L'activité commence dans 2-3 heures après injection
- C. A un pic maximal d'action de 3-8 h
- D. Durée d'action 12-18 heures
- E. Une durée d'action maximale de 7-15 heures

8. Les nodules d'ASCHOFF :

- ☒ a. Peuvent être retrouvées au niveau des poumons, du foie, des reins et au niveau de l'encéphale.
- ☒ b. Siègent sous l'endocarde.
- ☒ c. Ils comportent schématiquement deux zones : une zone centrale hyaline et une zone périphérique avec des cellules épithélioïdes.
- ☒ d. Ont une zone périphérique avec une couronne de lymphocytes, de monocytes et de polymorphonucléaires.
- ☒ e. Ont une zone moyenne avec des cellules épithélioïdes.

9. La chorée de SYDENHAM :

- ☒ A. Ne laissent jamais de séquelles neurologiques.
- ☒ B. Ce sont des mouvements involontaires, rapides, de grande amplitude.
- ☒ C. L'hypotonie, l'ataxie et les mouvements choréiques disparaissent lentement.
- ☒ D. L'hypotonie, l'ataxie et les mouvements choréiques disparaissent rapidement.
- ☒ E. C'est une manifestation du début de la maladie streptococcique.

10. Traitement du purpura rhumatoïde de l'enfant Henoch - Schönlein est :

- ☒ A. Pénicilliothérapie au long cours, benzathine pénicilline en injection intramusculaire toutes les trois semaines pendant 5 ans en l'absence de cardite et le plus longtemps possible si une cardite est associée.
- ☒ B. Amygdalectomie, traitement ou avulsion des dents mortifiées.
- ☒ C. Absence de traitement spécifique.
- ☒ D. Dans les formes digestives sévères : corticothérapie et nutrition parentérale.
- ☒ E. Dans les formes rénales, en fonction des résultats de la biopsie rénale, discussion entre l'abstention thérapeutique, la corticothérapie et les immunosuppresseurs.

11. Évolution de la maladie de Kawasaki est :

- ☒ A. La phase aiguë (J0-J10) : atteinte cardiaque rare.
- ☒ B. La phase aiguë (J0-J10) : constatation d'anévrismes et de sténoses cicatricielles en cas de complication coronaire à la deuxième phase.
- ☒ C. La phase subaiguë (J10-J20) : diagnostic de complication coronaire.
- ☒ D. La phase subaiguë (J10-J20) : atteinte cardiaque rare.
- ☒ E. La phase de convalescence (J20 -J70) : constatation d'anévrismes et de sténoses cicatricielles en cas de complication coronaire à la deuxième phase.

12. AJI forme oligo-articulaire

- ☒ A. La classification ILAR distingue 2 sous-groupes : une forme oligo-articulaire persistante et une forme extensive où l'atteinte peut devenir poly-articulaire avec l'évolution.
- ☒ B. Est définie par l'atteinte de cinq articulations.
- ☒ C. Est définie par l'atteinte de quatre articulations ou moins pendant les six premiers mois d'évolution de la maladie.
- ☒ D. Prédominant chez les garçons et sans association à la présence de FAN et un risque réduit d'iridocyclite.
- ☒ E. Prédominant chez les filles et s'associant à la présence de FAN et un risque élevé d'iridocyclite.

13. Les manifestations cliniques typiques pour la mucoviscidose sont :

- ☒ A. toux sèche
- ☒ B. diarrhée chronique avec stéatorrhée
- ☒ C. ictère méconial
- ☒ D. ictère prolongé
- ☒ E. obésité

14. Les causes de convulsions afebriles chez le nourrisson et le jeune enfant sont :

- ☒ A. Épilepsie
- ☒ B. troubles hydroélectrolytiques (natrémie, calcémie)
- ☒ C. frisson fébrile
- ☒ D. abcès cérébral
- ☒ E. thrombophlébite cérébrale

*15. Diagnostic de RAA :

- ☒ A. 2 critères majeurs sans associés à une preuve d'infection streptococcique récente
- ☐ B. 2 critères mineurs
- ☒ C. 2 critères majeurs ou 1 critère majeur et 2 critères mineurs associés à une preuve d'infection streptococcique récente
- ☐ D. Seulement 2 critères mineurs associés à une preuve d'infection streptococcique récente
- ☐ E. 1 critère majeur sans associés à une preuve d'infection streptococcique récente

16. Le syndrome néphrotique (SN) est défini par :

- ☐ A. une protéinurie < 50 mg/kg par 24 h
- ☒ B. une protéinurie > 50 mg/kg par 24 h
- ☐ C. hypoprotidémie > 60 g/L
- ☒ D. une hypoprotidémie < 60 g/L
- ☒ E. hypoalbuminémie < 30 g/L

17. Les indications de la PBR sont :

- ☐ A. Corticosensibilité (rémission complète)
- ☐ B. SN pur persistant
- ☒ C. SN impur persistant
- ☒ D. début avant l'âge de 1 an ou après l'âge de 11 ans
- ☒ E. début depuis l'âge de 1 an ou avant l'âge de 11 ans

18. Le recours à un traitement antithrombotique préventif est indiqué dans les situations à risque :

- ☒ A. Forme clinique sévère (anasarque)
- ☐ B. fibrinogène < 6 g/L
- ☒ C. albuminémie < 20 g/L
- ☐ D. antithrombine III $> 70\%$
- ☐ E. D-dimères < 1000 ng/mL

19. Les signes de gravité dans les infections urinaires sont :

- ☐ A. Nourrisson de moins de 3 mois d'âge
- ☐ B. Uropathie sous-jacente
- ☒ C. Pyonéphrose: reins volumineux et douloureux à la palpation de fosses lombaires
- ☒ D. Abscès rénal: Reins douloureux spontanément
- ☒ E. Immunodépression

20. Les signes orientant vers une cause potentiellement grave évoquant une cause centrale de l'anémie sont :

- ☒ A. syndrome hémorragique grave avec purpura
- ☐ B. ictère conjonctival
- ☒ C. fièvre, angine, stomatite
- ☐ D. urines rouges ou foncées
- ☒ E. syndrome tumoral : adénopathies, hépatosplénomégalie

21. Ne sont pas classés comme une anémie macrocytaire :

- ☒ A. Thalassémies Alfa ou bêta
- ☒ B. Anémie des maladies chroniques
- ☒ C. Anémie par carence en fer
- ☐ D. Anémie sans mégalo blastose osseuse (Hypothyroïdie, hépatopathie, l'alcoolisme, le méthotrexate, zidovudine)
- ☐ E. L'anémie par carence en vitamine B12 ou de l'acide folique

22. La carence en vitamine B12 est secondaire aux causes suivantes :

- ☐ A. L'apport des anti-épileptiques
- ☒ B. Malnutrition -souvent
- ☒ C. Pathologie du grêle distal (résection, maladie de Crohn)
- ☒ D. Pathologie du grêle proximal (résection, maladie coeliaque)
- ☐ E. L'apport de colchicine

23. Les manifestations d'insuffisance médullaire associée à thrombopénie sont :

- ☒ A. Purpura pétechiale
- ☒ B. Ecchymoses diffuses ou dans des sites inhabituels,
- ☐ C. Fièvre prolongée, angine récidivante
- ☒ D. Hématurie
- ☒ E. Asthénie, pâleur, éventuelle dyspnée

24. Manifestations en rapport avec un syndrome paranéoplasique du neuroblastome sont :

- ☒ A. Diarrhée (hypersécrétion de VIP)
- ☒ B. Syndrome opsomyoclonique
- ☒ C. Syndrome de Pepper
- ☒ D. Mouvements saccadés des yeux, ataxie
- ☐ E. Syndrome de Marfan

25. L'anémie normocytaire :

- ☐ A. Produit par carence en vitamine B12 ou de l'acide folique
- ☒ B. Anémie héréditaire / acquise
- ☐ C. Thalassémie Alfa ou bêta
- ☒ D. L'anémie aiguë post-hémorragique
- ☒ E. Anémie des maladies chroniques

26. Les causes de carence martiale chez l'enfant sont :

- ☒ A. Régime lacté exclusif prolongé
- ☐ B. Régime sans lacté prolongé
- ☒ C. Cardiopathie cyanogène
- ☐ D. Cardiopathie noncyanogène
- ☒ E. Maladie coeliaque, Autres diarrhées chroniques

27. Traitement curatif de l'endocardite infectieuse est :

- ☒ A. La durée du traitement endocardite à entérocoques : Pénicilline i.v. 4 semaines
- ☒ B. On commence le traitement avec la Pénicilline ou l'Oxacilline, plus la Gentamicine, injectable (intraveineuse).
- ☐ C. En cas d'allergie à la pénicilline, le traitement se fera avec la Gentamicine
- ☒ D. En cas d'allergie à la pénicilline, le traitement se fera avec la Vancomycine
- ☐ E. La durée du traitement en endocardite à staphylocoque : pénicilline injectable i.v. 4 semaines plus Gentamicine intrv. 2 semaines :

28. Causes non infectieuses de la myocardite sont :

- ☐ A. Rarement : champignons, rachitisme, protozoaires et parasites
- ☒ B. Maladies collagènes
- ☒ C. Allergiques, immuno-allergiques.
- ☐ D. Le virus de l'Epstein Barr, Cytomégalo virus, le virus de l'herpès
- ☒ E. Myocardite primitive FIEDLER

29. Les troubles à l'électrocardiogramme dans la péricardite sont les suivants :

- A. Hyper-voltage des complexes QRS
- B. Hypo-voltage des complexes QRS
- C. Changements caractéristiques variable au (I) du temps la dépression du segment ST
- D. Changements caractéristiques variable au (II) du temps comme l'élévation du segment ST
- E. Les extrasystoles et d'autres arythmies

30. La sténose pulmonaire isolée :

- A. Une malformation cardiaque congénitale cytogène
- B. Une malformation cardiaque congénitale non cytogène
- C. le patient peut être asymptomatique
- D. La dyspnée d'effort et la fatigue se produisent tout le temps
- E. La dyspnée d'effort et la fatigue se produisent uniquement si le débit cardiaque est insuffisant.

31. La tétralogie de Fallot est représentée par l'association de suivant lésions

- A. Le défaut septal interatrial péri-membraneux
- B. Le défaut septal interventriculaire péri-membraneux
- C. La sténose infundibulaire de l'aorte
- D. La sténose infundibulaire de l'artère pulmonaire
- E. L'hypertrophie ventriculaire droite

*32. Le signe pathognomonique dans la myocardite est :

- A. la taille du cœur normale = pointe arrondie, aorte dilatée et la stase rétrograde du poulmon.
- B. CA large - HTP, œdème pulmonaire, dilatation des cavités gauches
- C. Cardiomégalie et la pléthore pulmonaire
- D. Le cœur en « flash »
- E. L'ombre du cœur est augmenté par l'élargissement de l'AD et VD associé au pléthore pulmonaire

33. Dans le RGO, les rejets ou vomissements ont des caractéristiques évocatrices du diagnostic :

- A. Tout vomissement bilieux est un signe de RGO.
- B. Ne sont pas favorisés par l'alimentation liquide
- C. Favorisés par l'alimentation liquide
- D. Sont pas constantes
- E. Ne sont pas constantes

34. Les régimes thérapeutiques de l'infection par *Helicobacter pylori* de première ligne sont :

- A. La triple thérapie- Amoxicilline (50 mg / kg / jour) + Clarithromycine (15 mg / kg / jour) juste pour les cas sensible a clarithromycine + IPP, 2 doses / jour
- B. La triple thérapie-IPP + Lévofoxacin + Amoxicilline (50 mg / kg / jour) en 2 doses / jour.
- C. La quadruple thérapie-Amoxicilline (50 mg / kg / jour) + Métronidazole (30-40 mg / kg / jour) + sels de bismuth, 2 doses / jour
- D. La quadruple thérapie-IPP + Amoxicilline (50 mg / kg / jour) 5 jours, après IPP+ Clarithromycine (15 mg / kg / jour) ou Métronidazole (30-40 mg / kg / jour), 5 jours, 2 doses / jour.
- E. La thérapie séquentielle- IPP + Amoxicilline (50 mg / kg / jour) 5 jours, après IPP+ Clarithromycine (15 mg / kg / jour) ou Métronidazole (30-40 mg / kg / jour), 5 jours, 2 doses / jour.

35. La classification de la déshydratation aiguë est :
- A. Hyponatrémique- le déficit en sel est supérieur au déficit en eau : il s'agit d'une déshydratation à prédominance intracellulaire, hyponatrémique, isomolaire
 - B. Hyponatrémique- le déficit en sel est supérieur au déficit en eau : il s'agit d'une déshydratation à prédominance extracellulaire, hyponatrémique, hypo-osmolaire
 - C. Isonatrémique- le déficit en eau et en sel sont proportionnels : la déshydratation est globale, isonatrémique, iso-osmolaire
 - D. Isonatrémique- le déficit en eau et en sel sont proportionnels : la déshydratation hyponatrémique, hypomolaire
 - E. Hypernatrémique- le déficit en eau est proportionnellement supérieur au déficit en sel : il s'agit d'une déshydratation à prédominance intracellulaire, hypernatrémique, hyperosmolaire
36. La forme classique de la maladie cœliaque est caractérisée par la triade cœliaque
- A. La stéatorrhée
 - B. Constipation ou prolapsus rectal isolé
 - C. L'augmentation du volume abdominal
 - D. Les formes hypotrophiques, qui visent d'abord le poids et puis la taille
 - E. La malnutrition, auxquelles on ajoute l'apathie et l'irritabilité
37. Score Marsh, modifiée par Oberhuber dans la maladie cœliaque mettre l'accent sur :
- A. Le stade 0: l'architecture de l'intestin n'est pas affectée (maladie cœliaque potentielle ou latente)
 - B. Le stade 0: infiltration (infiltrat lymphocytaire dans le chorion)
 - C. Le stade 2: infiltration (infiltrat lymphocytaire dans le chorion)
 - D. Le stade 2- qui inclut l'atrophie villositaire partielle, subtotale ou totale - les sous-types IIa, IIb, respectivement IIc
 - E. Le stade 2: hyperplasie (des infiltrats lympho-plasmocytaires dans le chorion villositaire associés avec l'hyperplasie glandulaire)
38. Les examens sérologiques des maladies inflammatoires chroniques intestinales mettent l'accent sur :
- A. ASCA : positifs chez 3/4 de patients atteints de RCH
 - B. ASCA : positifs chez 2/3 de patients atteints de MC
 - C. ANCA : positifs chez 3/4 des patients atteints de RCH
 - D. ANCA : positifs chez 3/4 des patients atteints de MC
 - E. coproculture et virologie des selles, recherche de toxine *Clostridium difficile*
39. Les signes suivants peuvent suggérer une leucémie aiguë lymphoblastique :
- A. pâleur
 - B. hypotermie
 - C. hématurie
 - D. angine récidivante
 - E. hyperglycémie
40. La myocardite s'associe avec :
- A. bruits cardiaques étouffés, souffle systolique
 - B. wheezing
 - C. hypovoltage du complexe QRS
 - D. le cœur en « flash », avec d'angles obtus par rapport au diaphragme
 - E. silhouette cardiaque allongée
41. Dans la D-transposition classique de gros vaisseaux :
- A. l'aorte émerge du ventricule gauche
 - B. l'artère pulmonaire émerge du ventricule gauche
 - C. l'aorte émerge du ventricule droit
 - D. il ne faut pas exister un mélange du sang
 - E. la cyanose est grave dès la naissance

42. L'étiologie des vomissements aigus comprend :

- A. les infections ORI
- B. hypovitaminose A
- C. méningite
- D. infections respiratoires
- E. syndrome Down

43. Les antibiotiques recommandés pour les diarrées aiguës sont :

- A. Shigelle : ampicilline (100 mg/kg)
- B. Salmonelle : ceftriaxone (50 mg/kg)
- C. Shigelle : ibuprofène (20-30 mg/kg)
- D. Campylobacter jejuni : erythromycine (50 mg/kg) per os
- E. Salmonelle : Gentamycine 40 mg/kg

44. L'hépatite chronique avec virus B, dans la période inactive, non répliquant, se caractérise par la présence des :

- A. Ag HBs
- B. bAc anti-HBs
- C. Ag HBe
- D. ADN viral PCR
- E. Ac anti-HBe

45. L'hépatite C chronique a les suivantes caractéristiques sérologiques positives :

- A. Ac IgM anti-VHC
- B. Ac IgG anti-VHC
- C. Ig M-HBe
- D. Ig G-anti HBe
- E. ARN viral par PCR

46. Les manifestations cliniques dans le diabète associé à la fibrose kystique (DAFK) :

- a) Début insidieux, elle débute rarement en une acidocétose
- b) La détérioration de la fonction pulmonaire
- c) La polyurie et la polydipsie sont moins fréquentes
- d) Les complications du diabète spécifiques (micro et macro-angiopathie) sont fréquentes
- e) Augmentation de l'appétit, gain de poids, la fatigue

47. Les complications métaboliques de l'obésité idiopathique sont à l'exception de :

- a. Hepatostéatose
- b. Hypertension artérielle
- c. Syndr. ovaires polykystiques
- d. DZ type II
- e. Syndrome métabolique

48. Etiologie des pneumonies par group d'âge énumère :

- a. Nouveau née : Streptococ β grup B, v. syncytial respiratoire
- b. Ecotier : Streptococ pneumoniae, v. gripal
- c. Nourrisson : Chlamydia trachomatis, S β H
- d. Adolescents : Pneumocistis
- e. Petit enfants : virus rougeole

49. Les facteurs prédisposants pour l'apparition des pneumonies sont :

- a. Prematurité
- b. Reflux vesico-urétral
- c. Déficit immunitaire congénital ou acquis- traitements immunosuppresseurs
- d. Obésité
- e. Hyper gammaglobulinaémie

49. La physiopathologie de l'asthme implique :

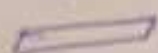
- ☒ a. la prédominance de la réponse de type Th2
- ☒ b. la formation de cytokines anti-inflammatoires
- ☒ c. l'activation des cellules B
- ☒ d. pour former des anticorps de type IgG
- ☐ e. dégranulation des éosinophiles et neutrophiles

50. Les caractéristiques de l'obésité idiopathique sont :

- ☒ a. Âge osseux normale ou avancé pour l'âge chronologique
- ☒ b. Antécédents familiaux d'obésité secondaire
- ☒ c. Symptômes évocateurs de la maladie qui peuvent être associés avec l'obésité
- ☒ d. Intelligence normale
- ☒ e. Haute stature généralement au-dessus du 50e percentile

- 1) ~~ABC~~ CD
- 2) BCD
- 3) ADE
- 4) BCE
- 5) ACE
- 6) ACD
- 7) CD
- 8) BDE
- 9) ~~ABC~~
- 10) CDE
- 11) ACE
- 12) CE
- 13) AB
- 14) AB
- * 15) C
- 16) BDE
- 17) CE
- 18) AC
- 19) CDE
- 20) AE

- 21) ABC
- 22) BC
- 23) ~~ABCD~~ D
- 24) ABD
- 25) BDE



- 26) AE
- 27) ~~AB~~ BD
- 28) BCE
- 29) BD
- 30) BCE
- 31) BDE

- * 32) D
- 33) CE
- 34) AD
- 35) BCE

- 36) ACE
- 37) AE
- 38) BC
- 39) ACD

- 40) ~~(ADE) (ACDE)~~
- 41) BCE
- 42) ABCD
- 43) ABD

- 44) AE
- 45) ABE
- 46) AC
- 47) ABCE
- 48) AC
- 49) AC
- 50) ADE

~~x 45 = B~~

~~V/A~~

Variant A)